Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 08:36
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 08:36
Temps mis	38 s
Points	2,50/12,00
Note	**4,17** sur 20,00 (**20,83**%)

Question 1

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

La recherche d'une maladie rénale chronique doit être dépistée annuellement chez les patients suivants :

- a. Insuffisants respiratoires ✖
- b. Éthyliques ✖
- c. Insuffisants cardiaques ✔
- d. Obèses avec un BMI supérieur à 30 ✔
- e. Diabétiques de type 2 ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Insuffisants cardiaques, Obèses avec un BMI supérieur à 30, Diabétiques de type 2

Question 2

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Parmi les items suivants, lesquels sont des causes d'aggravation de l'insuffisance rénale chronique ?

- a. Hypertension artérielle ✔
- b. Sédentarité ✖
- c. Ethylisme chronique ✖
- d. Diabète ✔
- e. Tabagisme ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Hypertension artérielle, Diabète, Tabagisme

---

Question 3

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Concernant la maladie rénale chronique :

- a. Elle concerne 7 à 10% de la population française. ✔
- b. Elle est souvent découverte à un stade évolué. ✔
- c. Elle augmente le risque de mortalité, notamment cardiovasculaire. ✔
- d. L'atteinte du débit de filtration glomérulaire entraine une modification du métabolisme de certains médicaments. ✔
- e. Le contrôle de l'hypertension artérielle dans ce contexte, nécessite de contrôler les apports sodés avec un objectif proche de 10 g/j. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Elle concerne 7 à 10% de la population française., Elle est souvent découverte à un stade évolué., Elle augmente le risque de mortalité, notamment cardiovasculaire., L'atteinte du débit de filtration glomérulaire entraine une modification du métabolisme de certains médicaments.

Question 4

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

En présence de signes d'atteinte rénale, il faut demander un avis spécialisé néphrologique en urgence :

- a. Devant un tableau de glomérulonéphrite rapidement progressive ✔
- b. Lorsque la protéinurie est supérieure à 1 g/g de créatininurie. ✖
- c. Lors d'une HTA résistante à un traitement par bloqueur du système rénine angiotensine aldostérone ✖
- d. Lorsque l'insuffisance rénale est aigue. ✔
- e. Lorsque le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 40 ml/min/1.73 m². ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Devant un tableau de glomérulonéphrite rapidement progressive, Lorsque l'insuffisance rénale est aigue.

Question 5

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

On peut affirmer la présence d'une maladie rénale devant :

- a. La présence d'un débit de filtration glomérulaire en dessous de 60 mm/min/1,73m² pendant plus d'1 mois. ✖
- b. Une hématurie à l'ECBU, après élimination d'une cause urologique, à plus de 10/mm^3 pendant plus de 2 mois ✖
- c. La découverte radiologique d'un petit rein bosselé ✔
- d. Une hématurie à l'ECBU, après élimination d'une cause urologique, supérieure à 10/mm^3 pendant plus de 3 mois ✔
- e. Un débit de filtration glomérulaire supérieur à 120 ml/min/1.73 m² pendant plus de 3 mois ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : La découverte radiologique d'un petit rein bosselé, Une hématurie à l'ECBU, après élimination d'une cause urologique, supérieure à 10/mm^3 pendant plus de 3 mois

---

Question 6

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Le suivi d'un patient insuffisant rénal chronique doit toujours comporter, au moins annuellement :

- a. Un ionogramme sanguin ✖
- b. Un dosage de la créatininémie ✔
- c. Un dosage du rapport albuminurie/créatininurie ✔
- d. Une échographie rénale ✖
- e. Un dosage de l'urée sanguine ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Un dosage de la créatininémie, Un dosage du rapport albuminurie/créatininurie

---

Question 7

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Le dépistage d'une pathologie rénale chez un sujet à risque doit comporter :

- a. Un dosage de la créatininémie ✔
- b. Un dosage de la créatininurie ✔
- c. Un dosage de l'albuminurie ✔
- d. Un scanner rénal sans injection ✖
- e. Un ionogramme sanguin ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Un dosage de la créatininémie, Un dosage de la créatininurie, Un dosage de l'albuminurie

Question 8

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Un homme de 55 ans vous consulte pour avoir votre avis sur sa fonction rénale. Il pèse 85 Kg pour 1 m 72. Il est suivi pour un diabète ancien avec des lésions rétiniennes. Sa tension artérielle est à 150/102 mmHg, le pouls à 74 battements/min. Le bilan biologique qu'il vous montre est le suivant :

- Na : 142 mmol/L
- K : 4,1 mmol/L
- Cl : 102 mmol/L
- CO3H- : 23 mmol/L
- Créatininémie : 126 umol/L
- Urée sanguine : 6 mmol/L

Dans les urines sur échantillon :

- Na : 80 mmol/l
- K : 40 mmol/L
- Cl : 100 mmol/L
- Créatinine : 6 mmol/L
- Protéinurie : 0,8 g/L

Compte tenu de ces éléments, que pouvez vous lui proposer pour optimiser la durée de fonctionnement rénal ?

- a. Privilégier les glifozines comme traitement anti-diabétique ✔
- b. Mieux contrôler sa tension artérielle ✔
- c. Proposer comme traitement anti-hypertenseur un bloqueur du système rénine-angiotensine ✔
- d. Lui demander de limiter ses apports en protéines ✔
- e. Lui demander d'avoir des boissons supérieures à 2 litres/jour ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Privilégier les glifozines comme traitement anti-diabétique, Mieux contrôler sa tension artérielle, Proposer comme traitement anti-hypertenseur un bloqueur du système rénine-angiotensine, Lui demander de limiter ses apports en protéines

Question 9

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Parmi les éléments radiologiques suivants, lesquels affirment une maladie rénale chronique ?

- a. Reins de petite taille ✔
- b. Reins avec disparition de la différentiation cortico-papillaire ✖
- c. Hypoperfusion rénale au doppler ✖
- d. Gros reins polykystiques ✔
- e. Asymétrie de taille entre les 2 reins ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Reins de petite taille, Gros reins polykystiques, Asymétrie de taille entre les 2 reins

---

Question 10

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Le suivi d'un patient insuffisant rénal chronique au stade 4 doit toujours comporter, au moins tous les 6 mois :

- a. Ionogramme sanguin ✔
- b. Parathormone ✔
- c. Hémoglobinémie ✔
- d. Ferritinémie ✔
- e. Cholestérolémie ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Ionogramme sanguin, Parathormone, Hémoglobinémie, Ferritinémie

---

Question 11

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

L'hypertension artérielle chez l'insuffisant rénal chronique:

- a. concerne plus de 50% des patients ayant un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml/min/1,73m². ✔
- b. Elle est indépendante des apports sodés. ✖
- c. doit faire privilégier un traitement par bloqueurs du système rénine angiotensine en 1ère intention. ✔
- d. L'objectif de tension artérielle doit être en dessous de 140 mmHg pour la systolique et de 90 mmHg pour la diastolique. ✔
- e. En présence d'une albuminurie supérieure à 300 mg/g (ou 30 mg/mmol) de créatinine, un objectif de 120 mmHg/80 mmHg est recommandé. ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : concerne plus de 50% des patients ayant un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml/min/1,73m²., doit faire privilégier un traitement par bloqueurs du système rénine angiotensine en 1ère intention., L'objectif de tension artérielle doit être en dessous de 140 mmHg pour la systolique et de 90 mmHg pour la diastolique., En présence d'une albuminurie supérieure à 300 mg/g (ou 30 mg/mmol) de créatinine, un objectif de 120 mmHg/80 mmHg est recommandé.

Question 12

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies ?

- a. On peut avoir une maladie rénale chronique avec un débit de filtration glomérulaire normal. ✔
- b. La présence, à plusieurs reprises et pendant plus de 3 mois, d'un débit de filtration glomérulaire entre 20 et 25 ml/min/1,73m² permet de classer l'insuffisance rénale au stade 4. ✔
- c. Le stade 5 d'évolution de la maladie rénale chronique est celui de l'insuffisance rénale terminale. ✔
- d. Un débit de filtration glomérulaire inférieur à 15 ml/min/1.73m² correspond à un stade 3B de la maladie rénale chronique. ✖
- e. Une mesure du débit de filtration glomérulaire par iohexol est indispensable pour connaitre le stade de la maladie rénale. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : On peut avoir une maladie rénale chronique avec un débit de filtration glomérulaire normal., La présence, à plusieurs reprises et pendant plus de 3 mois, d'un débit de filtration glomérulaire entre 20 et 25 ml/min/1,73m² permet de classer l'insuffisance rénale au stade 4., Le stade 5 d'évolution de la maladie rénale chronique est celui de l'insuffisance rénale terminale.